PHARMA MAGISTRAL NUTRI VET COSMETIC HOSPITALAR

VALDEQUÍMICA

LOVASTATINA

SINÔNIMOS/NOME QUÍMICO: Lovastatiini; Lovastatina; Lovastatinas; Lovastatine; Lovastatinum; Lovasztatin; (3*R*,5*R*)-7- {(1*S*,2*S*,6*R*,8*S*,8a*R*)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-2,6-dimethyl-8-[(*S*)-2-methylbutyryloxy]-1-naphthyl}-3-hydroxyheptan-5-olide; 6α-Methylcompactin; Mevinolin; MK-803; Monacolin K; MSD-803.
CAS: 75330-75-5
DCB: 05444
FÓRMULA MOLECULAR: $C_{24}H_{36}O_5$
PESO MOLECULAR: 404.5

INFORMAÇÕES GERAIS: É um fármaco regulador com ações sobre os lipídeos plasmáticos semelhantes aos da sinvastatina. É administrado em sua forma inativa e sofre biotranformação no organismo. Como todas as vastatinas, diminui a biossíntese endocelular do colesterol (inibição competitiva da enzima hidroximetilglutaril coenzima A redutase – HMG-CoA redutase) e incrementa o catabolismo do LDL (aumento de captação dos receptores da membrana celular). É bem absorvido pelo trato gastrointestinal, atinge concentração máxima em 2 a 4 horas e a ligação às proteínas plasmáticas é alta, sendo da ordem de 95% (BATISTUZZO,J. A., 2015).

INDICAÇÃO: A lovastatina é utilizada para reduzir os níveis elevados de triglicerídeos e colesterol quando a resposta à dieta for inadequada. Pode ser usada também no tratamento de hiperlipidemias, particularmente no tipo Hiperlipoproteinemias IIa e IIb. Também é dado para redução do risco cardiovascular em ambos e prevenção secundária de doença isquêmica do coração.

FAIXA DE DOSAGEM USUAL: A lovastatina é administrada por via oral em uma dose inicial de 10 a 20 mg diariamente à noite e associada à alimentos, aumentada, se necessário, em intervalos de 4 semanas ou mais a 80 mg por dia em dose única ou em 2 doses divididas. Doses mais baixas de lovastatina devem ser usadas em pacientes com risco de miopatia, incluindo pacientes com insuficiência renal grave e aqueles que tomam drogas que interagem com a mesma (SWEETMAN S. C., 2009).

Em crianças*:* A lovastatina também reduz as concentrações plasmáticas de colesterol em crianças e adolescentes com hipercolesterolemia. Tem sido administrada com segurança por até 48 semanas em meninos e 24 em meninas. Nos EUA, está autorizada para crianças e adolescentes de 10 a 17 anos por via oral, com uma dose diária inicial de 10 a 20 mg, podendo ser aumentada em intervalos de 4 semanas ou mais, se necessário, até uma dose máxima de 40 mg uma vez ao dia (SWEETMAN S. C., 2009).

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

SUGESTÃO DE FÓRMULA:

Lovastatina

Lovastatina.....10 a 20 mg
Excipiente qsp.....1 cápsula
Mande.....cápsulas

Modo de usar: 1 cápsula ao dia, após o jantar.

Lovastatina e Coenzima Q-10

Lovastatina.....10 a 20 mg
Coenzima Q-10.....50 a 100 mg
Excipiente qsp.....1 cápsula
Mande.....cápsulas

Modo de usar: 1 cápsula ao dia, apos o jantar.

Lovastatina uso tópico

Lovastatina.....2 g
Colesterol.....2 g
Propilenoglicol.....70 ml
Etanol 96° GL.....30 ml

Triturar os comprimidos de lovastatina e tamizar. Preparar uma solução com o propilenoglicol e o etanol e adicionar à mistura lovastatina-colesterol agitando até obter uma solução. Estabilidade de 14 dias sob refrigeração. Uso tópico.

EFEITOS ADVERSOS E PRECAUÇÕES: Como efeito adverso a Lovastatina apresentou histórico de abstinência em 21 pacientes de 745 que receberam a droga durante cerca de 5 anos. Eles incluíram elevação assintomática de insuficiência hepática aminotrasferase em 10 pacientes, sintomas gastrointestinais em 3, erupção cultânea em 2, miopatia em 2, mialgia em 1, artralgia em 1, insônia em 1 e ganho de peso em 1 (Lovastatin Study Groups I a IV. Arch Intern Med 1993; 153: 1079-87).

Em crianças: Apesar da existência de estudos comprovando a sua segurança e eficácia em crianças e adolescentes, como O Food and Drug Administration (FDA), que libera o uso de lovastatina e outras estatinas para crianças a partir de 10 anos que não atinjam a meta de LDL após seis meses de mudanças no estilo de vida, é sempre necessário consultar a prescrição e o prescritor. Vale ressaltar que o uso de estatinas não deve ser recomendado em crianças menores de 10 anos.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

Gravidez e amamentação: O uso da Lovastatina nos perídos de gestação e aleitamento é contraindicado, classificado com categoria de risco nível X.

INTERAÇÕES: Foram observadas reduções na depuração da lovastatina quando administrada com ciclosporina. Para pacientes em uso de ciclosporina ou danazol a dose inicial recomendada é de 10 mg por dia, de modo que a dose diária não deve exceder 20 mg em pacientes nessas codições, tomando ciclosporina, danazol e até derivados de ácido fíbrico ou ácido nicotínico. Para pacientes que fazem uso de amiodarona ou verapamil, a dose diária não deve exceder 40 mg.

FARMACOCINÉTICA: A lovastatina é absorvida pelo trato gastrointestinal e deve ser hidrolisada em seu β-hidroxiácido na forma ativa. Três outros metabólitos também foram isolados. A lovastatina é um substrato para o citocromo P450, isoenzima CYP3A4 e sofre extensa primeira passagem do metabolismo no fígado, seu principal local de ação; menos de 5% de uma dose oral foi relatada para atingir a circulação. As concentrações plasmáticas máximas ocorrem dentro de 2 a 4 horas, e as concentrações no estado estacionário são alcançado após 2 a 3 dias com a dosagem diária. Ambos, lovastatina e seu metabólito β-hidroxiácido, são mais do que 95% ligado às proteínas plasmáticas. A lovastatina é principalmente excretada na bile como metabólitos; cerca de 85% de uma dose foi recuperada das fezes e cerca de 10% da urina. A meia-vida do metabólito ativo é de 1 a 2 horas (SWEETMAN S. C., 2009).

REFERÊNCIAS:

SWEETMAN Sean C. ***Martindale, The Complete Drug Reference***; ed. 36ª. Editora Pharmaceutical Press, London, 2009.

SOUZA, Gilberto Barcelos. ***Formulário Farmacêutico Magistral***; 2ª Ed. Editora Medfarma. São Paulo, 2017.

BATISTUZZO, José Antônio, ITAYA Masayuki, ETO Yukiko, ***Formulário Médico-Farmacêutico***; 5ª Ed. Editora Atheneu. São Paulo, 2015.

RESOLUÇÃO-RDC Nº 354, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2003. **Ministério da Saúde**; disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2003/rdc0354_18_12_2003.html.

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 60, DE 17 *DE DEZEMBRO DE 2010.* **Ministério da Saúde**; disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2010/rdc0060_17_12_2010.pdf.

Texto atualizado em 07/08/2023, por Larissa Lopes.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.